

TEMA 4.6 • DERMATOLOGÍA

Rosácea

PERFIL EUNACOM 6.01.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Rosácea Cutánea Facial

Constituye una enfermedad inflamatoria vasomotora centrofacial idiopática, arraigada fuertemente a una combinación etiológica entrelazada entre el fotodaño solar histórico ultravioleta sostenido por años, un trasfondo inmunológico exagerado en cutis genético del individuo, sumado a un factor biológico exógeno parasitario irritativo detonante ocasionado por la convivencia simbiótica extrema de los **Ácaros de Folículo Piloso (Demodex folliculorum)**.

Presentación Clínica EUNACOM e Invasión Oftalmológica

A diferencia del Acné universal, la Rosácea excluye y **CARECE totalmente de la manifestación de Comedones / Puntos Negros**. (Salvo que estadísticamente haya mala fortuna y que un paciente cargue con el diagnóstico dual y concomitante de estar cursando Acné y de Rosácea en paralelo temporal simultáneo, cosa sumamente aislada).

- **Evolución por Grados Progresivos Estadios Anatómicos de Severidad Clínica:**
- **- Grado I (Rosácea Eritemato-Telangiectásica):** Base leve e inicial de enrojecimiento "rubor". Eritema facial rubicundo central persistente surcado e infestado por finas **Telangiectasias cutáneas** (arañas rojas / cordones venosos colapsados transparentes en pómulos capilares de la edad).
- **- Grados II y III (Rosácea Inflamatoria Activa Mod./Severa):** Engloba un estallido eruptivo crónico con aparición de un sarpullido eruptivo folicular ciego o con pus en torno al eritema: brotan abundantemente diseminadas en el centro del rostro y alas nasales **numerosas Pápulas rojas induradas y floramiento de Pústulas**. A semeja inmensamente a las secuelas activas del acné (recuérdese discriminar la ausencia de comedones de acné puro).
- **- Grado IV (Rosácea Fimatosa Extrema):** Instauración terminal del curso no tratado severamente. Engrosamientos atrófico hiperplásico fibrótico masivo deformante perimetral crónico de las glándulas subcutáneas crónicas de la anatomía cartilaginosa basal. Genera abultamientos tumorales asimétricos desastrosos blandos: destacando brutal y grotescamente a la **"Rinofima o Nariz de Frutilla Roja Abultada"**.
- **Complicación de Derivación Precoz Obligada EUNACOM en Oftalmología (Rosácea Ocular Paraneoplásica y Simbiótica):**
- **- Un porcentaje masivo de riesgo en pacientes aquejan el "traspaso" a las glándulas de los párpados culares (Las Glándulas de Meibomio), desatando graves queratopatías autoinmunes letales rojas: Generación crónica recurrente de Chalaziones oculares incontrolables, Blefaritis y orzuelos resecentes costrosos supurativos, constante irritación molesta como de "arenilla friccionadora en sacos oculares", e inclusive arrojando como daño postrero perforante catástrofes visuales en ceguera basal mediante Queratitis cicatricial irritativa difusa o severas Úlceras Corneales penetrantes rotas.**

Exacerbantes Irritantes Triggers (Gatillos de Flares Agudos)

Los pacientes asumen severos recambios exacerbadores en brote "flare-up" brusco inflamatorio que enrojecen drásticamente su eritema nasal basal sometidos frente al consumo de estos agentes vasodilatadores de alto estímulo: **La Invasiva Exposición Solar directa UVA sin filtro, ingesta de Condimentos y Alimentos hiperpicantes y el irrestricto Consumo Frecuente general crónico intermitente de Alcoholes Tragos**. Sumándose los bruscos y radicales traspasos agresivos de aire y choque por cambio de corrientes de Temperatura térmica estacionales extremas.

Escala de Tratamiento Dermatológico EUNACOM

- El asidero mandatorio generalizado general e innegociable basal se centra en el cambio crónico correctivo comportamental de sus desencadenantes, aplicando contundentemente a perennidad el **Uso Obligatorio Restrictivo de Bloqueador Solar Extremo diario**.
- Si un paciente exhibe una Rosácea Eritemato-Telangiectásica (I) predominando el enrojecimiento: Lograr palidecer estéticamente bloqueando la rubicundez recetándole tópicos potentes locales y temporales constrictivos (**El Vasoconstrictor Tópico Brimonidina Gel base de enjuague**). Así como fotocoagulación directa a pabellón en láser estético definitivo borrando capilar de base y curativo a las intrincadas frágiles paredes crónicas Telangiectásicas.
- **Inflamatoria Franca Severa (Grados II y III - Pápulas Reventosas Rojas y Pústulas):** Se interviene inmunizando e inmunomodulando rotundo por el largo plazo la reacción agresiva para barrer el Demodex con asimilación antibiótica basal cruzada: Escala Inmunológica de la Dermatología mundial base receta pilar indiscutida central curativa: **METRONIDAZOL TÓPICO En Gel Facial al 0,75% general de control local de Oro Absoluto e Inequívoco, sumado de requerirse por vía Inmunomoduladora cruzada antibiótica endovenosa Sistémica del espectro generalizada Oral de Tetraciclinas base como receto a largo crónica oral de DOXICICLINA**. En caso severo resistente refractario incesantemente crónico extremo fallido a estos frenos, obligan el escalamiento al citostático superior **Isotretinoína Oral crónico central supresor perenne de las sebáceas**.
- En Demodicosis masiva diagnosticada demostradas de ácaros (el Demodex fulminante letal asediando) exalta además del Metronidazol el combate parasitario frentísimo con Tópicos insecticidas letales sistémicos al nido de sarna general paralelos anclados a ungüentos concentrados escabicidas directos (**Las Cremas de Ivermectina cutánea local tóxica ácaro al 1% o su base equivalente Permetrina sintética tóxica residual**).
- La forma Fimatosa Plástica Terminal (Ej. En la Rinofima): Jamás logrará ser resuelta a las pastillas basales crónicas por la hiperplasia colagénica masca irreversible estructurada, exigiendo remoción plástica por **Láser quirúrgico abrasivo remodelante reconstructivo terminal de escultura**.
- *(Para la complicación oftálmica letal ocular grave de Meibomio rojas base y ulceraciones derivadas anexas asomadas incipientes obliga de mandato EUNACOM integral general paralizar el manejo basal asintomático inicial asediado remitiéndolo como indicación médica obligatoria de forma rápida siempre directísimo de interconsulta especialista al OFTALMÓLOGO).*

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la característica que diferencia la rosácea del acné vulgar en el examen físico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Rosácea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La rosácea no tiene comedones, lo que la diferencia fundamentalmente del acné vulgar.
- Los cuatro grados son: eritemato-telangiectásica, inflamatoria con pápulas y pústulas, y fimatosa con rinofima.
- El rinofima es el engrosamiento nasal característico del grado cuatro de la rosácea.
- Los desencadenantes son sol, cambios de temperatura, alcohol y alimentos condimentados.
- La rosácea puede producir complicaciones oculares graves como úlcera corneal por lo que requiere derivación.
- La brimonidina tópica trata solo el eritema y el metronidazol tópico trata las lesiones inflamatorias.
- Todo paciente con rosácea debe ser derivado al oftalmólogo para evaluar compromiso ocular.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ROSÁCEA)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la característica que diferencia la rosácea del acné vulgar en el examen físico?

- A)** La rosácea produce cicatrices queloides mientras el acné produce cicatrices atróficas
- B)** La rosácea afecta tronco y espalda mientras el acné solo afecta la cara
- C)** La rosácea no tiene comedones mientras el acné sí tiene comedones como lesión elemental
- D)** La rosácea produce ampollas tensas mientras el acné produce pústulas superficiales
- E)** La rosácea es autolimitada mientras el acné es una enfermedad crónica permanente

PREGUNTA 2

¿Cuál es la complicación más importante de la rosácea que obliga a derivar al paciente?

- A)** El melanoma facial asociado al daño actínico crónico acumulativo
- B)** La complicación ocular que puede producir chalazión, blefaritis o úlcera corneal
- C)** La transformación maligna de las lesiones inflamatorias a carcinoma espinocelular
- D)** La depresión mayor asociada al impacto cosmético de la enfermedad crónica
- E)** La infección bacteriana secundaria por estafilococo áureo resistente

PREGUNTA 3

¿Qué tratamiento se usa específicamente para el eritema de la rosácea?

- A)** Metronidazol tópico en gel al cero coma setenta y cinco por ciento
- B)** Doxiciclina oral en dosis de cien miligramos dos veces al día
- C)** Brimonidina tópica que actúa vasoconstrictora reduciendo el enrojecimiento
- D)** Corticoides tópicos de baja potencia para reducir la inflamación
- E)** Peróxido de benzoilo al cinco por ciento para tratar las pústulas

RESUMEN: ROSÁCEA

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Se presenta principalmente en adultos de piel clara y tiene cuatro grados o estadios progresivos. El grado uno o eritemato-telangiectásica presenta eritema persistente y telangiectasias. Los grados dos y tres son la forma inflamatoria con pápulas y pústulas pero sin comedones. El grado cuatro o fimatosa se caracteriza por el rinofima, es decir, el engrosamiento y deformación de la nariz en forma de fresa o coliflor. Los desencadenantes incluyen exposición solar, cambios de temperatura, alcohol y alimentos condimentados. La complicación ocular es importante: puede producir chalazión, blefaritis e incluso úlcera corneal, por lo que todo paciente con rosácea debe derivarse al oftalmólogo. El tratamiento se adapta a la forma clínica: la brimonidina tópica solo para el eritema, el metronidazol tópico para las lesiones inflamatorias, la doxiciclina oral para formas más extensas y el láser para el rinofima.